Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 2 · octobre 2026
p. 25–28 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE DE SYNTHÈSE

La psychothérapie centrée sur le sens en soins palliatifs

Conception, état des données probantes et questions de transférabilité

Samuel R. Ashford, Sora Pazer et Eleanor M. Whitcombe
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Outre les symptômes physiques, les personnes atteintes de maladies avancées et incurables sont fréquemment confrontées à une détresse existentielle, telle que le désespoir, la perte de sens ou le désir de mort anticipée. La psychothérapie centrée sur le sens (Meaning-Centered Psychotherapy, MCP), développée par William Breitbart et ses collaborateurs, est une intervention manualisée qui s'appuie explicitement sur la logothérapie de Viktor E. Frankl et vise à aider les patients à éprouver du sens même face à une espérance de vie limitée. Cette revue narrative décrit d'abord les fondements théoriques et la structure de l'intervention dans ses formats de groupe et individuel. Elle résume ensuite les données issues d'essais contrôlés randomisés, qui indiquent dans l'ensemble des effets favorables sur le bien-être spirituel, le sentiment de sens et la qualité de vie. Les limites de la recherche existante sont discutées, en particulier la concentration sur des populations et des systèmes de santé spécifiques, la gestion des abandons dans une population gravement malade et les questions de transférabilité culturelle. Enfin, la MCP est comparée à d'autres interventions d'orientation existentielle en soins palliatifs, telles que la thérapie de la dignité. L'article se conclut par des réflexions sur la mise en œuvre dans les pays germanophones et sur les qualifications requises des cliniciens.

Mots-clés : psychothérapie centrée sur le sens · soins palliatifs · psycho-oncologie · détresse existentielle · logothérapie

ABSTRACT

In addition to physical symptoms, people with advanced, incurable illnesses frequently face existential distress, such as hopelessness, loss of meaning, or a desire for hastened death. Meaning-centered psychotherapy (MCP), developed by William Breitbart and colleagues, is a manualized intervention that explicitly builds on Viktor E. Frankl's logotherapy and aims to help patients experience meaning even in the face of limited life expectancy. This narrative review first describes the theoretical foundations and the structure of the intervention in its group and individual formats. It then summarizes the evidence from randomized controlled trials, which overall points to favorable effects on spiritual well-being, sense of meaning, and quality of life. Limitations of the existing research are discussed, in particular the concentration on specific populations and health care systems, the handling of attrition in a severely ill population, and questions of cultural transferability. Finally, MCP is compared with other existentially oriented interventions in palliative care, such as dignity therapy. The paper concludes with considerations regarding implementation in German-speaking countries and the qualifications required of clinicians.

Keywords: meaning-centered psychotherapy · palliative care · psycho-oncology · existential distress · logotherapy

1 Introduction

Les soins palliatifs modernes se conçoivent comme un accompagnement global des personnes gravement malades, qui tient compte à parts égales des dimensions physique, psychologique, sociale et spirituelle de la souffrance. Les difficultés existentielles en fin de vie en particulier – l'expérience de l'absence de sens, le désespoir ou le désir de mort anticipée – posent des défis particuliers aux soignants, car elles ne peuvent trouver de réponse dans les seules mesures orientées vers les symptômes. Yalom (1980) a décrit la confrontation avec sa propre finitude comme une préoccupation ultime centrale de l'existence, qui devient inéluctable face à une maladie limitant l'espérance de vie.

C'est dans ce contexte que la psychothérapie centrée sur le sens (Meaning-Centered Psychotherapy, MCP) a été développée au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. Elle compte parmi les rares interventions centrées sur le sens à avoir été étudiées dans plusieurs essais contrôlés randomisés et constitue ainsi un point de référence important pour la discussion de la base de données probantes des procédures d'inspiration logothérapeutique. La présente contribution offre un aperçu narratif de sa conception et de l'état de la recherche et s'interroge sur sa transférabilité à d'autres contextes de soins.

Sur le plan conceptuel, la détresse existentielle peut être distinguée de la dépressivité, même si les deux peuvent se recouvrir. Le désespoir, la perte de sens ou le sentiment d'être un fardeau pour autrui peuvent survenir chez des personnes gravement malades même en l'absence du tableau complet d'un trouble dépressif. Il en résulte un besoin d'interventions qui prennent explicitement pour objet les thèmes existentiels.

2 Fondements théoriques

La MCP se réfère explicitement à l'œuvre de Viktor E. Frankl. Ses présupposés centraux sont que la quête de sens représente une motivation humaine fondamentale, que le sens peut être éprouvé même dans des conditions de souffrance grave et de temps de vie limité, et que les personnes conservent la liberté de choisir leur attitude face à des circonstances inéluctables (Frankl, 1946/2006). Breitbart et Poppito (2014) traduisent les catégories de valeurs de Frankl en sources de sens concrètes, explorées systématiquement au cours de l'intervention : des sources de sens historiques, au sens de l'héritage de sa propre vie ; des sources de sens d'attitude, dans la manière de faire face aux limites de la vie ; des sources de sens créatrices, au sens de la responsabilité et de l'engagement ; et des sources de sens d'expérience, dans l'amour, la beauté et l'humour.

En outre, la MCP peut être comprise dans le cadre du modèle d'élaboration de sens de Park (2010). Un diagnostic limitant l'espérance de vie peut créer un profond décalage entre les objectifs de vie globaux et la situation actuelle. La MCP peut être comprise comme un soutien structuré aux processus d'élaboration de sens, qui ne nient pas ce décalage, mais l'inscrivent dans un contexte de sens plus large.

Une autre idée fondamentale est la distinction entre ce qui ne peut être changé face à la maladie et ce qui reste ouvert à l'action. L'intervention invite les participants à percevoir les deux : reconnaître les limites sans perdre de vue les possibilités restantes. On y retrouve l'idée de Frankl selon laquelle le sens peut être réalisé non seulement dans l'action et dans l'expérience, mais aussi dans l'attitude face à l'inéluctable.

3 Structure de l'intervention

Le format de groupe, la Meaning-Centered Group Psychotherapy (MCGP), comprend huit séances hebdomadaires, chacune consacrée à un thème (Breitbart & Poppito, 2014). Les séances associent des éléments didactiques, dans lesquels sont transmis des concepts de la logothérapie, à des exercices expérientiels et à des discussions de groupe. Le programme commence par une exploration du concept de sens et de la question de savoir comment la maladie a modifié l'expérience du sens. Suivent des séances sur les différentes sources de sens, le travail sur son propre héritage jouant un rôle particulièrement important. Le programme se conclut par une réflexion sur le processus commun et un regard sur les espoirs pour le temps restant.

Pour les patients pour lesquels la participation à un groupe n'est pas possible, un format individuel, l'Individual Meaning-Centered Psychotherapy, a été développé ; il prévoit une séquence de séances plus courte et peut être adapté de manière plus souple à l'évolution de la maladie (Breitbart et al., 2012). La manualisation facilite la formation des praticiens et la réalisation d'études contrôlées, mais exige en même temps un haut degré de jugement clinique afin d'adapter la structure aux besoins individuels des personnes gravement malades.

Un élément caractéristique de l'intervention est le travail sur un projet d'héritage. Les participants sont invités à élaborer un projet qui exprime leur vie et leurs valeurs et qui renvoie au-delà de leur propre temps de vie – par exemple consigner des souvenirs, se réconcilier avec une personne proche ou mener un projet créatif. Cet élément relie les valeurs créatrices décrites par Frankl à la question de savoir ce qui reste d'une vie (Breitbart & Poppito, 2014).

4 État des données probantes

La première étude pilote randomisée a comparé la MCGP à une psychothérapie de groupe de soutien chez des patients atteints d'un cancer avancé (Breitbart et al., 2010). Les résultats ont indiqué des avantages de la condition centrée sur le sens en ce qui concerne le bien-être spirituel et le sens vécu ; il y avait en outre des indices d'une diminution du désespoir et du désir de mort. Une étude pilote du

format individuel a également montré des résultats favorables par rapport à une condition contrôle (Breitbart et al., 2012).

Un essai randomisé de plus grande taille, avec une psychothérapie de groupe de soutien active comme condition de comparaison, a pour l'essentiel confirmé cette orientation des résultats (Breitbart et al., 2015). Le groupe centré sur le sens a montré des avantages en ce qui concerne le bien-être spirituel et la qualité de vie, ainsi que des indices d'une réduction de la dépressivité, du désespoir et du désir de mort anticipée. Il est notable que les différences sont apparues par rapport à une condition contrôle active qui contenait elle-même des facteurs non spécifiques tels que la cohésion de groupe et le soutien émotionnel. Des interventions centrées sur le sens de ce type ont également été incluses dans la méta-analyse des thérapies existentielles de Vos et al. (2015) et ont contribué au tableau d'ensemble favorable des interventions structurées centrées sur le sens.

Dans le même temps, il faut garder à l'esprit les limites de ces résultats. Les études ont été menées principalement dans un centre d'oncologie spécialisé aux États-Unis. Dans une population gravement malade, les abandons d'étude dus à la progression de la maladie ou au décès sont inévitables, ce qui complique l'interprétation des données longitudinales. Enfin, la question de savoir dans quelle mesure les résultats peuvent être transposés à d'autres groupes diagnostiques, systèmes de santé et contextes culturels reste ouverte.

Un autre aspect concerne le choix des critères de résultat. Outre des mesures de symptômes, les études ont utilisé en particulier des instruments portant sur le bien-être spirituel et la qualité de vie. Ce choix correspond à l'objectif de l'intervention, mais doit être pris en compte dans les comparaisons avec d'autres procédures psychothérapeutiques visant principalement la réduction des symptômes. La question de savoir quelles composantes de l'intervention sont responsables des changements observés n'a pas non plus encore reçu de réponse définitive.

5 Délimitation par rapport aux interventions apparentées

Parmi les interventions d'orientation existentielle en soins palliatifs, la thérapie de la dignité (Dignity Therapy) est devenue particulièrement connue aux côtés de la MCP (Chochinov et al., 2005). Elle vise à renforcer le sentiment de dignité en fin de vie et travaille avec un entretien structuré dont résulte un document écrit pouvant être transmis aux proches. Les deux approches partagent l'accent mis sur l'héritage et la revue de vie. La MCP est toutefois conçue de manière plus psychoéducative, comprend plusieurs séances et poursuit l'objectif de renforcer l'expérience du sens également au regard du temps de vie restant, alors que la thérapie de la dignité est plus concise et orientée vers la création d'un document de générativité.

Les deux interventions ont en commun de comprendre les thèmes existentiels non comme un simple effet secondaire de troubles mentaux, mais comme un objet à part entière des soins palliatifs. Elles se distinguent en cela d'une approche purement psychopathologique, qui considère la détresse existentielle principalement du point de vue d'une dépression ou d'une anxiété comorbide. Dans la pratique, le choix entre les approches peut dépendre du temps de vie restant, des capacités physiques et des préférences des patients.

6 Implications pour les soins dans les pays germanophones

Plusieurs questions se posent pour la mise en œuvre dans les pays germanophones. Premièrement, une adaptation linguistique et culturelle soigneuse est nécessaire, qui tienne compte de la diversité religieuse et idéologique et ne présuppose pas implicitement une conception particulière du sens. Deuxièmement, la mise en œuvre impose des exigences élevées aux praticiens : outre la compétence psychothérapeutique, la familiarité avec les questions existentielles, l'expérience de l'accompagnement des mourants et la capacité d'autoréflexion face à sa propre finitude sont indispensables. Troisièmement, l'introduction devrait s'accompagner d'une évaluation qui saisisse non seulement l'évolution des symptômes, mais aussi l'expérience du sens, le bien-être spirituel et l'acceptation de l'intervention par les patients et les proches.

Dans l'ensemble, la MCP peut servir d'exemple de la manière dont des idées fondamentales de la logothérapie peuvent être traduites en une intervention précisément décrite et vérifiable. Les résultats disponibles sont encourageants, mais ne justifient pas une généralisation au-delà des contextes étudiés. D'autres réplications indépendantes dans différents systèmes de santé sont souhaitables.

Les proches et les personnes endeuillées entrent également en ligne de compte comme groupes cibles d'interventions centrées sur le sens. Le transfert à ces groupes est conceptuellement évident, puisqu'ils sont

eux aussi confrontés à la perte, à l'adieu et aux questions sur le sens de ce qui est arrivé ; les données à ce sujet restent toutefois limitées et nécessitent des recherches supplémentaires.

Références

Breitbart, W., Poppito, S., Rosenfeld, B., Vickers, A. J., Li, Y., Abbey, J., Olden, M., Pessin, H., Lichtenthal, W., Sjoberg, D., & Cassileth, B. R. (2012). Pilot randomized controlled trial of individual meaning-centered psychotherapy for patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 30(12), 1304–1309.

Breitbart, W., & Poppito, S. R. (2014). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A treatment manual. Oxford University Press.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 19(1), 21–28.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Chochinov, H. M., Hack, T., Hassard, T., Kristjanson, L. J., McClement, S., & Harlos, M. (2005). Dignity therapy: A novel psychotherapeutic intervention for patients near the end of life. Journal of Clinical Oncology, 23(24), 5520–5525.

Frankl, V. E. (2006). Man's search for meaning. Beacon Press. (Original work published 1946)

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Meaning-Centered Psychotherapy in Palliative Care: Conception, State of the Evidence, and Questions of Transferability. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 25–28.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.